PROTOCOLLO 84

Bruxismo da veglia

Ridurre serramento e digrignamento diurni con un approccio comportamentale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Bruxismo da veglia, mialgia	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Serramento riferito o osservato
- ✓ Mialgia che aumenta nella giornata
- ✓ Usura o ipertrofia del massetere

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Valutazione
Questionario, osservazione e monitoraggio con promemoria.



Educazione
Spiega il ruolo del carico muscolare nel dolore.



Consapevolezza
Promemoria frequenti e posizione di riposo.



Trattamento
Terapia miofasciale ed esercizi di rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Monitoraggio	promemoria ogni 30 a 60 minuti
Durata	4 a 6 settimane
Rivalutazione	ogni 2 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il bruxismo è un comportamento, non una malattia
- ✓ La consapevolezza è l'intervento principale
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Prescrivere solo il bite per il bruxismo diurno
- ! Colpevolizzare il paziente
- ! Ignorare i fattori di stress

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Controllo con promemoria	A ogni avviso: labbra chiuse, denti separati, lingua al palato	ogni 30 a 60 minuti

! **Nota clinica.** Il consenso internazionale distingue bruxismo da veglia e da sonno: richiedono strategie diverse.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.